

TXA：时间与方案

成人创伤活动/疑似严重出血；从受伤起算。

≤3 h；1 g 静滴 ≥10 min → 1 g 静脉维持 8 h

尽早使用；国内 R33 维持表述为“8 h以上”，欧洲 R23 为8 h。

超3 h、疑纤溶关闭或特殊人群：交由团队按来源与本院规范重新判断。

按本院药品说明书、配制及输注流程执行；不得快速静推。

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

欧洲创伤大出血指南第六版（2023）

成人出血：血压目标

止血前、无颅脑/脊髓损伤的成人初期出血。

SBP 80–90 mmHg

老年、慢性高血压慎重；儿童与孕妇另按专门方案。

灌注持续恶化或合并神经损伤：重新定目标并升级止血。

国内R22与欧洲R13支持有条件的目标；不是所有伤者通用。

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

欧洲创伤大出血指南第六版（2023）

休克指数

成人风险识别，结合查体与趋势。

$$SI = HR / SBP ; \text{国内 } SI \geq 1$$

国内R2将≥1列入诊断条件；欧洲R5讨论0.9–1附近风险。

药物抑制心率或老人“正常”生命体征仍保留休克担心。

不凭单个指数排除出血或决定输血。

创伤失血性休克中国急诊专家共识 (2023)

欧洲创伤大出血指南第六版 (2023)

大量输血启动评估

成人；ACS TQIP 评分示例。

ABC ≥2 + 临床状态

穿透躯干伤、FAST阳性、HR >120、SBP <90各1分；核对本院版本。

持续不稳定或活动出血需止血也可触发评估，不等累计输血量。

国内支持早期血液管理与本院流程；未据此声称ABC为全国统一启动标准。

ACS TQIP 大量输血指南

创伤失血性休克中国急诊专家共识 (2023)

国家卫健委：临床用血技术规范 (2025年版)

纤维蛋白原

严重活动出血，或黏弹性检测提示功能性缺乏。

Clauss Fib ≤ 1.5 g/L + 大出血

欧洲R29：评估纤维蛋白原/冷沉淀补充并复测。

出血持续、检测恶化：血库/凝血团队按本院方案升级。

国内围术期共识：严重渗血冷沉淀条款为 <1.5 ，纤维蛋白原条款为 $<1.5-2.0$ ；场景及边界不同。

欧洲创伤大出血指南第六版 (2023)

围术期出血管理麻醉专家共识

输血时 Hb 目标

成人创伤，需要红细胞输注时的欧洲R16目标。

Hb 70–90 g/L

结合活动出血、灌注与病程；早期Hb正常不能排除大出血。

TBI、心肌缺血及特殊人群按专科目标；不等Hb下降才启动抢救。

国内2025用血规范要求个体评估与输后评价，不能据其声称全国统一70–90目标。

欧洲创伤大出血指南第六版 (2023)

国家卫健委：临床用血技术规范 (2025年版)

离子钙

成人大出血，尤其大量输血。

iCa：维持本实验室正常范围

复测血气iCa并结合pH，按本院补钙方案纠正。

输血仍在进行、iCa下降或心律变化：及时团队复评。

欧洲R31与国内围术期3.8均强调监测/正常化；本页不统一药品或补钙剂量。

欧洲创伤大出血指南第六版（2023）

围术期出血管理麻醉专家共识

重型颅脑伤：灌注目标

重型TBI (GCS ≤ 8) ；不能套用允许性低血压。

MAP ≥ 80 mmHg

国内2023 R22另列SBP >110 ；2026院前R6写SBP ≥ 110 或MAP ≥ 80 。

意识/瞳孔变化、目标未达：同步纠正氧合/灌注并升级神经救治。

已有ICP监测时结合CPP等个体目标；MAP不是完整神经监护方案。

创伤失血性休克中国急诊专家共识 (2023)

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识 (2026)

欧洲创伤大出血指南第六版 (2023)

老年：提早警惕隐匿休克

老年创伤高风险识别/分诊提示，不等于单独确诊休克。

≥65 岁；SBP <110 mmHg

补问抗凝、基线功能、降压/控心率药及头部受伤。

低能量伤合并症状、抗凝或灌注异常：提早高级评估。

110阈值源于重伤院前共识；髌部指南仅作国内骨科后续路径入口。

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

国家卫健委：老年髌部骨折诊疗与管理指南（2022年版）

抗凝药：识别后逆转路径

危及生命/不可控出血或紧急高风险手术；由授权团队决策。

药名 → 末次剂量 → 出血严重度

华法林：PCC + 静脉维K；达比加群：依达赛珠单抗；Xa药：特异拮抗剂或PCC路径。

同步查肾功能、INR/TT/抗Xa及本院药品可及性；正常PT不能排除DOAC效应。

Xa具体药物、适应证与可及性按本院药事/血库方案核对；不对每名服药者自动逆转。

欧洲创伤大出血指南第六版（2023）

围术期出血管理麻醉专家共识

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

孕妇创伤：母体与产科并行

子宫增大至脐水平/以上；Rh阴性且未致敏的腹部/重大创伤。

母体优先；子宫左推；Rh D

有效按压同时人工左推；抗D由产科按孕周、致敏状态、胎母出血与本院方案评估。

母体不稳定、腹痛/流血或胎心担心：创伤—产科共同升级。

尚未核实覆盖这些具体条款的国内同等指南；保留国际参考标识，本院产科流程确认。

Queensland：妊娠创伤指南

AHA 2025：妊娠心脏骤停

孕妇心停：复苏性分娩

子宫底在脐水平/以上且标准复苏未获ROSC。

识别心停即准备；目标 ≤5 min 完成

AHA2025：在心停现场组织产科/麻醉/新生儿团队与复苏性分娩。

传统4 min启动/5 min娩出是历史时间框架；不等4 min才叫人或准备。

本院需预先落实团队、物资与演练；不是所有孕周的自动手术指令。

AHA 2025：妊娠心脏骤停

儿童：体重与首轮复苏

RCH儿童重大创伤，循环不足的首轮等渗液体评估；并行识别出血。

实测/近期体重；晶体液 10 mL/kg

无法称重按本院验证的身长体重工具；RCH持续出血可用RBC 10 mL/kg初始小份。

每份后复评；持续失血尽早血库/儿科MTP，不重复大量晶体液。

国内重症失血性休克成分方案见下一卡；常规RBC 10–15表不适用于急救大出血。

RCH：儿童重大创伤初评

WS/T 795—2022 儿科输血指南

儿童：国内失血性休克输血索引

WS/T795—2022 §9.5.2.2：儿童创伤性失血性休克。

RBC：FFP = 1：1 (容量)

标准举例RBC 20 mL/kg + FFP 20 mL/kg；不是常规贫血或非创伤比例。

持续出血按标准及本院儿科MTP补充其他成分；结果返回后调整并监测容量超负荷。

此为成分容量方案示例，与RCH首轮小份的阶段不同；核对产品规格和本院儿童流程。

WS/T 795—2022 儿科输血指南

烧伤：中国新九分法

头面颈、双上肢、躯干含会阴、双下肢含臀足。

成人： $9 + 18 + 27 + 46 = 100\%$

12岁以下：头面颈=9+(12-年龄)%；双下肢=46-(12-年龄)%。

面积或深度不确定、关键部位/吸入/电化学伤：烧伤专科复评。

按2025版规范表1及§2.1；补液面积只计II/III度，不将I度纳入。

国家卫健委：突发事件烧伤伤员医疗救治规范（2025年版）

烧伤：国内成人补液公式

国内2025规范晶胶混合公式；II/III度，%填百分数数值。

首24 h： $1.5-2\text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{TBSA} + 2000\text{ mL}$

晶:胶=1-2:1；总估算量一半在伤后首8 h，余量分后两个8 h。

按灌注、尿量和过负荷反馈调整；成人公式不套儿童/心肾病。

1.5是该版范围下限，不是唯一固定量；已输入液体计入总量，以本院烧伤流程为准。

国家卫健委：突发事件烧伤伤员医疗救治规范（2025年版）

抢救、告知与交接文书

仅限因抢救急危患者未能及时书写；不是所有病历可延迟。

抢救结束后 ≤6 h 据实补记并注明

时间到分钟；措施、反应、人员、告知与交接责任。

签署困难记录原因并走合法授权/急救审批流程，不造签名或回填时间。

病历规范第22条(八)、25/27条；输血告知同步遵循2025用血规范。

病历书写基本规范 (2010)

国家卫健委：临床用血技术规范 (2025年版)

抢救室：到院前

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

角色：床头 / 胸部 / 循环 / 记录

确认空间、监护、血库与高级支援

交接：机制、发现、已做、未知

升级：立即威胁或资源不能覆盖需求

WHO 创伤救治核对单与团队交接

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

xABCDE：每轮回看

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

x出血 → A气道/保护 → B呼吸 → C循环 → D神经 → E暴露/保暖

具体事实 + 趋势 + 责任人

措施后核查有效性，补齐未知区域

恶化：回到初评，同时升级

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

骨盆：并行识别风险

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

看灌注、开放伤与胸腹其他失血源

束带技能：适用场景、位置、复评与失败升级

联系骨科 / 止血 / 泌尿 / 软组织团队

本土队列用于讨论，不能替代患者决策

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

IJEM 2025 多发伤骨盆骨折研究

救治链：跨节点不断线

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

先明确接收能力与负责人

交接已知 / 未知 / 担心 / 下一次复评

移动前核查监护、气道、出血与装备

资源堵塞或患者变化：重新定去向

WHO 创伤救治核对单与团队交接

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

灾难：患者与系统双复评

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

需求是否超过可用能力？

更新人数、空间、血液、手术、转运

患者：趋势 / 新发现；系统：瓶颈 / 新危险

用本院认可分诊工具，变化后再评

WHO 创伤救治核对单与团队交接

复苏：四项并行

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

止血与资源调度

早期TXA / 血液 / 凝血监测

保暖、iCa、灌注与措施后反应

数字分别见成人/TBI口袋卡

创伤失血性休克中国急诊专家共识 (2023)

欧洲创伤大出血指南第六版 (2023)

二次 / 三次：防漏诊

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

稳定后：AMPLE + 从头到脚查体

标明未评区域、影像待定与限制

重复查体、核对正式报告，指派责任人

新症状/恶化先回xABCDE；不等下一班

RCH：二次评估

WHO 创伤救治核对单与团队交接

特殊人群：先分组

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

老年：抗凝 / 低能量重伤 / 基线功能

儿童：体重 / 年龄 / 血液方案

妊娠：母体优先 / 产科并行

烧伤：深度 / 中国九分法 / 专科复评

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）
WS/T 795—2022 儿科输血指南
国家卫健委：突发事件烧伤伤员医疗救治规范（2025年版）
Queensland：妊娠创伤指南

交接：写得出，接得住

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

发现与时间；措施与反应

未知事项与复评期限

告知 / 同意 / 接收者确认

抢救补记条件与6小时见文书卡

病历书写基本规范（2010）

国家卫健委：临床用血技术规范（2025年版）

骨盆MDT病例：分步复盘

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

区分原材料记载与课堂推演

出血与开放伤风险并行

解释协作节点与复评责任

资料缺失不补造；队列归属未确认

IJEM 2025 多发伤骨盆骨折研究

技能：从决定到复评

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

判断时机 → 准备与授权 → 关键步骤

效果核查 → 失败识别 → 求助升级

0未做到 / 1提示后做到 / 2独立完整

只在监督下模拟；评分不等于临床授权

NICE NG39 重大创伤

颅脑：神经与ABC联动

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

记录意识、瞳孔与运动的变化

避免低氧/低灌注；压力目标见TBI卡

核对抗凝、用药和基线状态

新神经变化：高级气道/神经团队复评

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

胸部：双侧对照

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

呼吸费力、胸廓起伏与呼吸音

床旁发现与监护趋势一起报告

操作由授权人员，措施后再查

呼吸/灌注迅速恶化：立即团队升级

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

腹部：保留隐匿出血担心

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

机制、腹部查体、灌注与变化

单次阴性FAST不能排除腹部损伤

按稳定性与本院路径组织再查/影像

恶化：初评、止血与外科同步

NICE NG39 重大创伤

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

多发伤：全局排序

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

各轴发现并列，避免单一区域吸引全部注意

每项行动明确责任人和效果核查

稳定后补二次/三次评估

新发现与资源变化触发重新排序

WHO 创伤救治核对单与团队交接

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

腹部病例：用趋势复盘

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

已知发现与推测分别列出

串联灌注、影像与血液资源

解释每次选择后还需核查什么

无改善：重新寻找出血源并升级

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

NICE NG39 重大创伤

休克复评：改善了吗？

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

灌注、神经、出血与体温一起看

记录措施—时间—反应

区分预设病例趋势与真实治疗效果

恶化/未知持续：并行团队复评

创伤失血性休克中国急诊专家共识（2023）

颈椎与髋：神经血管复查

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

记录疼痛、运动、感觉和远端灌注

移动和干预前后复查并留痕

关联机制，补查其他区域

新神经/灌注异常：骨科/脊柱升级

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

骨科：先全身后局部

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

先识别xABCDE立即威胁

局部查体与神经血管状态

临时保护后复查，继续找合并伤

开放伤、缺血、神经异常：高级评估

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

脊柱：保护与动态神经查体

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

机制、疼痛、运动感觉与可信度

移动限制按风险/本院标准

移动前后记录神经变化

新无力/感觉异常或灌注恶化：升级

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

上肢：前后对照查体

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

伤口、畸形、运动、感觉、灌注

覆盖开放伤，临时保护与镇痛讨论

固定前后记录神经血管

缺血、疼痛不相称/进行性神经异常：升级

NICE NG39 重大创伤

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

下肢：局部与全身风险

分层课程速记；规培关键步骤与模拟须有监督，按本院流程。

失血、开放伤、神经血管与疼痛

老人低能量髌部伤也补查抗凝/基线功能

固定/移动后复查；核对去向和责任人

缺血或持续恶化：升级；国内髌部路径另查

国家卫健委：老年髌部骨折诊疗与管理指南（2022年版）

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

球囊面罩：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

双人配合、密封与胸廓反应

持续检查氧合/通气，准备下一气道方案

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

插管：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

准备、预氧合、备选方案与团队角色

管位确认与持续监测；失败及时进入救援路径

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

紧急颈前气道：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

识别不能插管且不能氧合情境并呼叫支援

模型练习解剖、器械与效果核查

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

胸部减压：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

综合临床怀疑与呼吸/灌注变化

减压后查效果；无效重新评估与升级

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

胸腔引流：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

适用判断、准备、监督下关键步骤

效果、引流系统、并发症与复查

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

EFAST：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

标准窗逐项看；记录质量与未见窗口

阴性不排除损伤，结合稳定性与重复检查

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

止血带：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

识别危及生命的肢体外出血

控制效果、时间、远端与交接记录

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

骨盆束带：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

疑骨盆伤与循环风险，核对本院适用条件

模拟位置核查、皮肤风险、效果与持续复评

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤

临时固定：技能口袋卡

监督下模型训练；真实操作按本院授权与技能课来源。

固定前后神经血管查体并记录

疼痛/灌注变化或新感觉异常及时升级

授权、监督、失败方案先说清

OSCE：0未做 / 1提示 / 2完整；重错单列

中华医学会相关学组：重伤院前救治共识（2026）

NICE NG39 重大创伤